

Judul:

Pengembangan Sistem Skrining *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD) Berbasis *Website* Menggunakan Pendekatan *Rule-Based* dan *Chatbot* untuk Anak Usia Dini di Tegal.

Sumber yang dipakai:

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5 (DSM-5).

Tingkat keparahan ADHD:

1. Inatensi
2. Hiperaktivitas – Impulsivitas
3. Inatensi & Hiperaktivitas – Impulsivitas (Campuran)

Catatan: Dinyatakan berisiko ADHD jika mempunyai 6 gejala dari tipe tsb.

Kriteria Diagnosis

Menurut DSM-5, kriteria diagnosis ADHD adalah:

1. Pola inatensi dan atau hiperaktivitas-impusivitas yang persisten dan mengganggu fungsi atau perkembangan dengan 6 atau lebih gejala menetap selama sedikitnya 6 bulan hingga menyebabkan gangguan perkembangan dan memiliki efek negatif langsung terhadap aktivitas sosial dan akademik
2. Beberapa gejala inatensi atau hiperaktivitas-impusivitas ada sebelum usia 7 tahun
3. Beberapa gejala inatensi atau hiperaktivitas-impusivitas ditemukan pada setidaknya 2 *setting*, seperti rumah, sekolah, pekerjaan, dengan teman, keluarga, atau aktivitas lain
4. Terdapat bukti nyata bahwa gejala mengganggu atau menurunkan kualitas kehidupan sosial, akademik, dan pekerjaan
5. Gejala tidak timbul selama episode [schizophrenia](#) atau gangguan psikotik lain dan tidak memenuhi kriteria gangguan mental lainnya.

Gejala terkait inatensi antara lain:

1. Sering gagal memperhatikan detil atau sering membuat kecerobohan di kegiatan sekolah, pekerjaan, atau aktivitas lain
2. Sering kesulitan memusatkan perhatian pada tugas atau aktivitas bermain
3. Sering terlihat tidak mendengarkan ketika diajak bicara
4. Sering tidak mengikuti instruksi dan menyelesaikan tugas sekolah, rumah, atau pekerjaan
5. Sering kesulitan mengorganisir tugas dan aktivitas

6. Sering menghindari, tidak menyukai, atau malas melakukan pekerjaan yang membutuhkan usaha mental, misalnya menyusun laporan atau esai
7. Sering kehilangan benda-benda yang penting untuk tugas atau aktivitas
8. Sering mudah terdistraksi oleh stimulus eksternal
9. Sering pelupa pada aktivitas harian

Gejala terkait hiperaktivitas-impulsivitas antara lain:

1. Menggeliat saat duduk atau bermain-main dengan kaki atau tangan seperti mengetuk-ngetukkan jemari dan terus bergerak
2. Sering meninggalkan tempat duduk pada kondisi dimana anak diharapkan tetap duduk diam, misalnya saat belajar di sekolah
3. Sering berlalu atau memanjat pada situasi yang tidak tepat
4. Sering tidak mampu untuk bermain atau beraktivitas yang membutuhkan ketenangan
5. Sering terlihat seperti dikendalikan oleh mesin atau seperti tidak mudah merasa lelah
6. Banyak bicara
7. Menjawab sebelum pertanyaan selesai
8. Sulit menunggu giliran
9. Menyela atau mengganggu percakapan dan aktivitas orang lain.

Pertanyaan untuk kuesioner skrining:

A. Inatensi (Usia 4–6 Tahun)

1. Anak sulit fokus saat bermain atau melakukan satu kegiatan.
2. Anak mudah teralihkan oleh suara atau benda di sekitarnya.
3. Anak tampak tidak mendengarkan saat dipanggil atau diajak bicara.
4. Anak tidak menyelesaikan kegiatan yang sedang dilakukan (misalnya mewarnai atau menyusun mainan).
5. Anak sering berpindah aktivitas sebelum selesai.
6. Anak kesulitan mengikuti instruksi sederhana (misalnya “rapikan mainan”).
7. Anak sering kehilangan atau lupa meletakkan mainan atau barangnya.
8. Anak tampak pelupa terhadap kegiatan sehari-hari.
9. Anak kesulitan duduk dan memperhatikan saat guru bercerita.

Jawaban pertanyaan:

0 = Tidak pernah

1 = Jarang

2 = Sering

3 = Sangat sering

B. Hiperaktivitas – Impulsivitas (Usia 4–6 Tahun)

1. Anak sering bergerak terus-menerus dan sulit diam.
2. Anak sering berlari atau memanjat pada situasi yang tidak sesuai.
3. Anak sulit duduk tenang saat makan atau belajar.
4. Anak sulit bermain dengan tenang.
5. Anak terlihat memiliki energi berlebih dibandingkan anak seusianya.
6. Anak sering berbicara berlebihan atau bersuara keras.
7. Anak sulit menunggu giliran saat bermain.
8. Anak sering merebut mainan atau menyela teman.
9. Anak sering bertindak tanpa berpikir (misalnya langsung melakukan sesuatu tanpa izin).

Jawaban pertanyaan:

0 = Tidak pernah

1 = Jarang

2 = Sering

3 = Sangat sering

C. Kriteria Tambahan (Konteks DSM-5)

1. Perilaku tersebut terjadi sebelum usia 6 tahun.
2. Perilaku muncul di lebih dari satu tempat (rumah dan sekolah/PAUD).
3. Perilaku tersebut mengganggu aktivitas belajar atau bermain anak.

Jawaban pertanyaan:

0 = Tidak

1 = Ya

Guide Interview:

A. Dasar Teoretis & Validitas DSM-5

1. Apakah DSM-5 dapat dijadikan landasan dalam penyusunan instrumen skrining ADHD untuk anak usia dini (4–6 tahun)?
2. Secara akademis, bagaimana kriteria diagnosis ADHD menurut DSM-5 untuk anak usia dini?

B. Kriteria & Indikator ADHD

1. Gejala apa saja yang secara klinis termasuk dalam kategori ADHD pada anak usia dini?
2. Apakah seluruh 18 gejala dalam DSM-5 relevan untuk diterapkan pada anak usia 3–6 tahun?
3. Dalam praktik klinis, bagaimana membedakan perilaku aktif normal dengan gejala ADHD pada anak usia dini?

C. Tingkat Keparahan & Klasifikasi

1. Bagaimana cara menentukan tingkat keparahan ADHD (ringan, sedang, berat) dalam praktik klinis?
2. Apakah penentuan tingkat keparahan cukup berdasarkan jumlah gejala, atau juga mempertimbangkan tingkat gangguan fungsi sosial dan akademik?

D. Alternatif Instrumen & Validasi

1. Selain DSM-5, adakah instrumen lain yang umum digunakan untuk skrining ADHD pada anak usia dini?
2. Apakah pendekatan skrining berbasis kuesioner yang diisi oleh orang tua/guru sudah cukup representatif untuk deteksi awal?

E. Etika & Batasan Sistem

1. Apakah sistem skrining berbasis website dapat membantu sebagai deteksi awal sebelum konsultasi profesional?
2. Batasan apa saja yang perlu dicantumkan agar sistem tidak disalahartikan sebagai alat diagnosis?